# Corrigé de gynécologie obstétrique

Examen blanc INFAS Abengourou Octobre 2026 Licence 3 SFM Version D

Corrigé avec questions, propositions, réponses, explications et sources. Les numéros de page des cours renvoient aux pages du fichier PDF, couverture comprise. Les références en ligne sont détaillées à la fin du document.

## Questions à choix double

Pour chaque affirmation : A = Vrai ; B = Faux. Réponse juste : +1 point ; réponse fausse : −1 point ; absence de réponse : 0 point.

**Question 1. L'hydramnios est un facteur de risque de procidence du cordon.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : L’excès de liquide favorise la mobilité fœtale et une présentation haute ; lors de la rupture des membranes, le cordon peut descendre devant la présentation.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Procidence du cordon, facteurs favorisants », p. PDF 104.

**Question 2. Dans l’accouchement du siège, la manœuvre de Løvset peut être utilisée pour dégager des bras relevés et les épaules retenues.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : La manœuvre de Løvset mobilise le tronc fœtal afin de dégager les bras et les épaules dans certaines difficultés de l’accouchement du siège.

Source : MSF, Soins obstétricaux et néonatals essentiels, section 6.1 Présentation du siège, manœuvre de Løvset.

**Question 3. L'infertilité se définit comme l'absence de survenue d'une grossesse après 1 an de rapports sexuels réguliers sous contraception.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : L’infertilité se définit par l’absence de grossesse après au moins 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. L’expression « sous contraception » rend l’affirmation fausse.

Source : OMS, Infertility, définition clinique ; Multiple definitions of infertility, 2020.

**Question 4. L’avortement spontané peut se compliquer d’une hémorragie.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Un avortement spontané peut provoquer des saignements importants, notamment en cas d’expulsion incomplète. Une hémorragie grave n’est toutefois pas constante.

Source : INFAS, GYNECO L1 .pdf, « Avortement spontané, signes cliniques et conduite à tenir », p. PDF 89–93.

**Question 5. La ménarche précoce est un facteur de risque de cancer du sein.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Une ménarche précoce allonge la durée d’exposition hormonale au cours de la vie, ce qui constitue un facteur de risque de cancer du sein.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Tumeur du sein, facteurs de risque et longue vie hormonale », p. PDF 142.

**Question 6. Lors de l’ovulation humaine, le gamète féminin libéré est un ovocyte II.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : L’ovocyte I reprend sa méiose et donne un ovocyte II avec émission du premier globule polaire. L’ovocyte II est libéré lors de l’ovulation.

Source : INFAS, GYNECO L1 .pdf, « Ovogenèse », p. PDF 35–36.

**Question 7. Une corticothérapie anténatale, lorsqu’elle est indiquée devant un risque d’accouchement prématuré, accélère la maturation pulmonaire fœtale.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Les corticoïdes anténatals accélèrent la maturation pulmonaire lorsque la prématurité est probable et que les critères d’utilisation sont réunis. Ils ne sont pas administrés à toutes les gestantes.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Menace d’accouchement prématuré, corticothérapie », p. PDF 100.

**Question 8. Dans la rupture utérine, le toucher vaginal doit être réalisé avec prudence pour ne pas déclencher une hémorragie cataclysmique.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Le risque classique d’hémorragie déclenchée par un toucher vaginal digital concerne un placenta prævia. Une suspicion de rupture utérine impose une prise en charge obstétricale urgente.

Source : MSF, Soins obstétricaux et néonatals essentiels, section 3.1 Placenta prævia ; INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Traumatismes et grossesse », p. PDF 116.

**Question 9. L’enfant exposé au VIH, confirmé non infecté et sans autre contre-indication, doit bénéficier des vaccins du programme élargi de vaccination.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : L’exposition maternelle au VIH n’exclut pas la vaccination de l’enfant non infecté. Une infection confirmée avec déficit immunitaire impose en revanche une évaluation spécifique des vaccins vivants, notamment du BCG.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « VIH et grossesse, soins au nouveau-né », p. PDF 126. OMS, Use of BCG vaccine in HIV-infected infants.

**Question 10. Les fibromes sous-séreux sont le plus souvent responsables de ménorragies.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Ce sont surtout les fibromes sous-muqueux, au contact de la cavité utérine, qui provoquent des règles abondantes. Les fibromes sous-séreux donnent plutôt des signes de volume ou de compression.

Source : CNGOF, Interventions gynécologiques, section Hystéroscopie opératoire.

**Question 11. Dans la cystite isolée, l'infection est localisée au niveau du bas appareil urinaire.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : La cystite est une infection de la vessie, qui appartient au bas appareil urinaire. Une fièvre ou une douleur lombaire doit faire rechercher une atteinte plus haute.

Source : Collège français des urologues, Référentiel d'urologie, 6e édition, chapitre 11 Infections urinaires.

**Question 12. Dans les grossesses gémellaires bizygotes, plus la division de l'œuf est tardive, plus elle pourra aboutir à des siamois.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Les jumeaux dizygotes proviennent de deux fécondations distinctes. Les jumeaux conjoints résultent d'un développement anormal d'une grossesse monozygote, et non de la division d'un œuf dizygote.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Grossesse gémellaire, embryologie et classification », p. PDF 8–10.

**Question 13. La révision utérine ne peut pas être réalisée après une césarienne par risque de couper les fils de l'hystérorraphie.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Une césarienne antérieure n'interdit pas absolument une exploration utérine si elle est indiquée. Celle-ci est réalisée avec précaution par un professionnel formé, en tenant compte de la cicatrice.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Délivrance artificielle et révision utérine », p. PDF 57–59. MSF, section 7.4 Utilisation de l'oxytocine pendant le travail, utérus cicatriciel.

**Question 14. La rupture utérine est la principale cause des métrorragies du 3e trimestre de grossesse.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : La rupture utérine est une urgence grave, mais les grandes causes classiques de métrorragies du troisième trimestre comprennent le placenta prævia et l'hématome rétroplacentaire.

Source : MSF, Soins obstétricaux et néonatals essentiels, chapitre 3 Saignements pendant la deuxième moitié de la grossesse.

**Question 15. Dans le modèle habituel de transmission du système ABO, deux parents de génotype OO ne peuvent avoir que des enfants de groupe O.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Dans le modèle génétique ABO usuel, chaque parent OO transmet un allèle O. Le croisement OO × OO donne donc des enfants OO, de groupe O.

Source : NCBI Bookshelf, Blood Groups and Red Cell Antigens, chapitre The ABO blood group.

**Question 16. Le port du préservatif est un moyen de prévention de la rubéole au cours de la grossesse.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : La rubéole se transmet principalement par voie respiratoire. Sa prévention repose sur la vaccination avant la grossesse ou après l’accouchement ; le vaccin vivant est contre-indiqué pendant la grossesse.

Source : OMS, Rubella, sections Transmission et Vaccination.

**Question 17. Les ébauches de l'appareil génital ne sont pas identiques chez l'embryon féminin et masculin.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Les ébauches génitales passent d’abord par un stade morphologiquement indifférencié commun. La différenciation ultérieure dépend notamment du programme génétique et des signaux hormonaux.

Source : ENS de Lyon, La différenciation sexuelle morphologique, section Stade de la gonade indifférenciée.

**Question 18. L’aplasie müllérienne bilatérale complète, dans sa forme totale, est associée à une agénésie rénale bilatérale incompatible avec la vie.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : La forme totale de l’aplasie müllérienne bilatérale est décrite avec une agénésie rénale bilatérale, incompatible avec la vie. Elle doit être distinguée du syndrome de Rokitansky, qui est une forme incomplète.

Source : GFMER, Diagnostic échographique des malformations utérines, diapositive Aplasies müllériennes, p. PDF 16.

**Question 19. La ménopause peut s’installer sans bouffées de chaleur ni autres troubles climatériques ressentis.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Certaines femmes ne ressentent aucun trouble climatérique. L’absence de bouffées de chaleur n’empêche donc pas la ménopause ; l’arrêt des règles reste le repère clinique principal.

Source : Société française d’endocrinologie, Item 124 Ménopause et insuffisance ovarienne prématurée, sections Périménopause, Diagnostic et Signes cliniques.

**Question 20. Le traitement antiviral chez une gestante porteuse du virus de l'hépatite B est toujours obligatoire.**

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : La positivité de l’AgHBs impose un bilan. L’indication d’un antiviral dépend notamment de l’état hépatique et du risque de transmission, évalué par la charge virale ou les marqueurs disponibles.

Source : OMS, Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection, 2024, prévention de la transmission mère-enfant.

## Questions à choix multiple

Choisir la ou les réponses exactes. Lire toutes les propositions avant de répondre.

**Question 21. Les situations suivantes peuvent être à l'origine d'une mort fœtale in utero : lesquelles ?**

A. Grossesse prolongée.

B. Dépassement de terme.

C. Accouchement prématuré.

D. Accouchement à terme.

Réponse : A et B

Explication : La prolongation excessive de la grossesse augmente le risque de mort fœtale. Un accouchement prématuré ou à terme ne constitue pas, à lui seul, une cause de décès in utero.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Souffrance fœtale aiguë, causes fœtales », p. PDF 85. CNGOF, Mort fœtale, 2024, facteurs de risque.

**Question 22. Quel examen confirme une mort fœtale in utero en objectivant l'absence d'activité cardiaque fœtale ?**

A. Diminution du volume utérin.

B. Montée laiteuse.

C. Disparition des mouvements fœtaux.

D. Échographie obstétricale.

E. Absence de bruit du cœur fœtal à l'auscultation.

Réponse : D

Explication : L'échographie confirme le diagnostic en visualisant l'absence d'activité cardiaque. L'absence de mouvements ou de bruits cardiaques à l'auscultation constitue un signe d'alerte, insuffisant seul.

Source : CNGOF, Mort fœtale, 2024, champ 3 Évaluation fœtale et champ 4 Examen échographique.

**Question 23. Quelle complication hématologique faut-il rechercher devant une mort fœtale in utero associée à un sepsis ou à un hématome rétroplacentaire ?**

A. Infection amniotique.

B. Coagulopathie, notamment coagulation intravasculaire disséminée.

C. Trouble psychologique.

Réponse : B

Explication : Le sepsis et l'hématome rétroplacentaire exposent à une CIVD. La durée de rétention seule ne permet pas d'affirmer qu'un trouble de coagulation apparaît systématiquement après deux semaines.

Source : CNGOF, Mort fœtale — consensus formalisé d'experts, 2024, champs 4 et 5, p. PDF 50–51.

**Question 24. Selon l'EDS de Côte d'Ivoire de 2021, quel est le rapport de mortalité maternelle estimé pour 100 000 naissances vivantes ?**

A. 614

B. 512

C. 385

D. 215

Réponse : C — 385 décès pour 100 000 naissances vivantes

Explication : L'EDS 2021 estime ce rapport à 385 pour la période de référence de l'enquête. La valeur 614 correspond à l'EDS 2011–2012.

Source : INS et ICF, EDS Côte d'Ivoire 2021, Rapport de synthèse, rubrique Mortalité maternelle ; OMS Afrique, Côte d'Ivoire améliorer la qualité des soins, 5 décembre 2024.

**Question 25. Le décès maternel est le décès d'une femme pendant la grossesse ou dans les combien de jours suivant sa terminaison, pour une cause déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, à l'exclusion des causes accidentelles ou fortuites ?**

A. 32 j

B. 42 j

C. 52 j

D. 62 j

Réponse : B — 42 jours

Explication : La définition retient la grossesse et les 42 jours suivant sa terminaison, quelle que soit sa durée ou sa localisation, avec un lien causal à la grossesse ou aux soins associés.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Mortalité maternelle, définition », p. PDF 127.

**Question 26. Quels aspects la mortalité maternelle permet-elle d'apprécier, en tant qu'indicateur sanitaire et de développement ?**

A. L'âge moyen de survie de l'ensemble de la population.

B. La qualité et l'accessibilité des soins obstétricaux.

C. Les conditions de développement social et économique.

D. Le nombre exact de femmes alphabétisées.

E. L'état de santé maternelle de la population.

Réponse : B, C et E

Explication : Cet indicateur renseigne sur la santé maternelle, les soins et les inégalités sociales. Il ne mesure directement ni l'espérance de vie de toute la population ni un effectif de femmes alphabétisées.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Mortalité maternelle, facteurs et stratégies », p. PDF 127–129.

**Question 27. Les causes des décès maternels suivantes sont des causes directes : lesquelles ?**

A. Perforation utérine suite à un avortement provoqué.

B. Placenta prævia hémorragique.

C. Hématomes péri-génitaux.

D. Neuropaludisme.

E. Hémoglobinopathie.

Réponse : A, B et C

Explication : Les lésions et hémorragies obstétricales sont des causes directes. Le neuropaludisme et les hémoglobinopathies sont des maladies non obstétricales pouvant constituer des causes indirectes lorsqu'elles sont aggravées par la grossesse.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Mortalité maternelle, causes directes et indirectes », p. PDF 127–128.

**Question 28. Parmi les propositions ci-dessous, lesquelles font partie des stratégies nationales de lutte contre les décès maternels ?**

A. La planification familiale.

B. La CPN de qualité.

C. Bonne application des SONU.

D. Audit et revue des décès maternels.

E. Accouchements non assistés par un personnel qualifié.

Réponse : A, B, C et D

Explication : La PF, le suivi prénatal de qualité, les SONU et les revues de décès font partie des stratégies de réduction des décès maternels. Un accouchement sans personnel qualifié augmente le risque.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Stratégies nationales de lutte contre les décès maternels », p. PDF 128–129.

**Question 29. L'audit des décès maternels permet de : cocher les bonnes réponses.**

A. Identifier les dysfonctionnements.

B. Sanctionner les auteurs des dysfonctionnements.

C. Faire des recommandations.

D. Améliorer la qualité des soins.

Réponse : A, C et D

Explication : La revue recherche les facteurs évitables et débouche sur des actions d'amélioration. Elle repose sur la confidentialité et une démarche sans blâme, distincte d'une procédure de sanction.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Audit et revue des décès maternels », p. PDF 129. OMS et UNICEF, Maternal and perinatal death surveillance and response, 2021.

**Question 30. Parmi les facteurs suivants de décès maternels, lesquels font partie du deuxième retard ?**

A. Croyances socioculturelles.

B. Sous-estimation des symptômes.

C. Mauvais état des routes.

D. Coût du transport.

E. Manque de médicaments.

F. Absence de personnel qualifié.

Réponse : C et D

Explication : Le deuxième retard correspond à la difficulté d'atteindre une structure de soins : routes, distance, transport et coût. La décision relève du premier retard ; les insuffisances de soins relèvent du troisième.

Source : INFAS, GYNECO L1 .pdf, « SONU, les trois retards », p. PDF 75–76.

## Cas clinique

Mme Ko Y., 18 ans, G2P1, de groupe A Rhésus négatif, est enceinte de 27 SA. Elle présente une rupture prématurée des membranes depuis une semaine. Malgré les conseils reçus, elle a retardé sa décision de consulter ; aucun obstacle de transport n'est rapporté. Elle est admise avec une altération de l'état général et une fièvre évoluant depuis deux jours. L'échographie confirme une mort fœtale in utero et l'examen évoque une chorioamniotite sévère. L'utérus n'est pas cicatriciel. L'équipe commence immédiatement la prise en charge du sepsis, dont une antibiothérapie intraveineuse, et réalise les prélèvements et bilans sans retarder les soins. L'évacuation utérine est organisée rapidement. Les questions 31 à 35 se rapportent à cette situation.

**Question 31. Quel retard est principalement mis en évidence par l'audit du cas clinique ?**

A. Un premier retard.

B. Un 2e retard.

C. Un 3e retard.

Réponse : A — Premier retard

Explication : La patiente a retardé la décision de consulter après la rupture des membranes. Le transport disponible et les soins commencés immédiatement ne documentent pas ici un deuxième ou un troisième retard.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Prévention de la mortalité maternelle, les trois retards », p. PDF 129.

**Question 32. Parmi les propositions suivantes, laquelle serait pertinente pour évacuer la cavité utérine ?**

A. Abstention.

B. Aspiration par AMIU.

C. Césarienne.

D. Déclenchement du travail d'accouchement.

Réponse : D

Explication : L’infection impose de faire naître sans délai injustifié, parallèlement au traitement maternel. La voie basse par déclenchement est privilégiée en l’absence d’indication chirurgicale.

Source : CNGOF, Mort fœtale — consensus formalisé d’experts, 2024, champs 4 et 5, p. PDF 50–51.

**Question 33. Dans le cas décrit ci-dessus, deux éléments sont des facteurs de risque d'hémorragie du post-partum. Lesquels ?**

A. Fièvre.

B. Infection amniotique.

C. L'âge.

D. La mort in utero.

E. Le Rhésus négatif.

Réponse : B et D

Explication : La chorioamniotite favorise l’atonie utérine. Une mort fœtale, notamment associée à un sepsis, peut s’accompagner de troubles de coagulation. Le Rhésus négatif n’est pas en lui-même un facteur d’HPP.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Hémorragie du post-partum, causes », p. PDF 110. CNGOF, Mort fœtale — consensus formalisé d’experts, 2024, champs 4 et 5, p. PDF 50–51.

**Question 34. Quels médicaments ou classes de médicaments peuvent être indiqués au cours de la prise en charge de cette patiente, selon l’étape et le protocole obstétrical ?**

A. Oxytocine, notamment après l’expulsion pour prévenir ou traiter l’atonie utérine.

B. Furosémide systématique en l’absence d’indication cardiopulmonaire.

C. Misoprostol pour le déclenchement selon le protocole adapté au terme.

D. Antibiothérapie intraveineuse à large spectre adaptée au sepsis.

E. Antispasmodique comme traitement de l’infection amniotique.

F. Bétaméthasone pour la maturation pulmonaire d’un fœtus dont le décès est confirmé.

Réponse : A, C et D

Explication : Les antibiotiques traitent l’infection ; le misoprostol peut servir au déclenchement et l’oxytocine à la prévention ou au traitement de l’atonie. Les corticoïdes de maturation n’ont pas

d’indication pour un fœtus décédé.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Rupture prématurée des membranes, antibiothérapie », p. PDF 94. INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Hémorragie du post-partum », p. PDF 110–111.

**Question 35. Après stabilisation et expulsion fœtale, quelles méthodes peuvent être proposées en post-partum immédiat à cette patiente qui n’allaite pas ?**

A. MAMA.

B. DIU.

C. Progestatif injectable.

D. Implant.

Réponse : C et D

Explication : Après stabilisation, implant et injectable progestatif sont possibles chez une femme qui n’allaite pas. La MAMA est inapplicable après ce décès fœtal ; le DIU est contre-indiqué en contexte de sepsis puerpéral.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Administration des CHP et contre-indications au DIU », p. PDF 76–77 et 90.

**Question 36. Parmi les affections suivantes pouvant survenir au cours de la grossesse, la ou lesquelles sont d'origine parasitaire ?**

A. Rubéole.

B. Syphilis.

C. Toxoplasmose.

D. Paludisme.

E. Hépatite B.

Réponse : C et D

Explication : Toxoplasma gondii et les Plasmodium sont des parasites. La rubéole et l’hépatite B sont virales ; la syphilis est bactérienne.

Source : CDC, About Toxoplasmosis ; OMS, Malaria, Rubella et Hepatitis B, rubriques Définition et agents responsables.

**Question 37. Chez une femme immunocompétente, quelles infections peuvent entraîner une immunité acquise durable après une primo-infection ?**

A. Rubéole.

B. Syphilis.

C. Toxoplasmose.

D. Paludisme.

Réponse : A et C

Explication : La rubéole entraîne habituellement une immunité durable. Une infection toxoplasmique ancienne confère généralement une protection chez l’immunocompétente, sans exclure toute réinfection ou réactivation. La syphilis et le paludisme ne confèrent pas une protection durable complète.

Source : CDC, Pink Book, chapitre 20 Rubella, Immunity ; CDC, DPDx Toxoplasmosis et Symptoms of Toxoplasmosis.

**Question 38. Une sérologie toxoplasmique réalisée au premier trimestre montre des IgM négatives et des IgG positives. Quelle est l’interprétation habituelle la plus probable ?**

A. Absence d'infection.

B. Infection récente débutante.

C. Infection ancienne.

D. Infection évolutive.

Réponse : C — Infection ancienne

Explication : Au premier trimestre, ce profil est habituellement en faveur d’une infection ancienne. Il ne date pas précisément l’infection ; un contexte douteux justifie une interprétation spécialisée ou des examens complémentaires.

Source : CDC, DPDx Toxoplasmosis, section Laboratory Diagnosis, interprétation des IgG et IgM.

**Question 39. Quel virus fait l’objet d’une prévention spécifique de la transmission mère-enfant par la vaccination du nouveau-né dès la naissance ?**

A. Virus de l’hépatite A.

B. Virus de l’hépatite B.

C. Virus de l’hépatite C.

D. Virus de l’hépatite E.

Réponse : B — Hépatite B

Explication : La vaccination anti-VHB dès la naissance est une mesure majeure de prévention de la transmission mère-enfant. Les mesures supplémentaires dépendent du statut infectieux maternel.

Source : OMS, Hepatitis B et Mother-to-child transmission of hepatitis B prevention.

## Bilan prénatal

Les résultats de sérologie de l’hépatite B d’une autre gestante sont : AgHBs négatif, Ac anti-HBs positif à un titre protecteur d’au moins 10 mUI/mL, Ac anti-HBc négatif. Son schéma vaccinal complet est documenté et elle est immunocompétente. Les questions 40 à 42 se rapportent à ce bilan.

**Question 40. Cette situation correspond à : (choisir la bonne affirmation)**

A. Femme non vaccinée.

B. Femme vaccinée.

C. Femme avec hépatite chronique.

D. Femme avec hépatite B guérie.

Réponse : B — Femme vaccinée

Explication : Des anti-HBs isolés, avec AgHBs et anti-HBc négatifs, correspondent au profil d’une immunité vaccinale lorsqu’un schéma complet est documenté.

Source : CDC, Screening and Testing for Hepatitis B Virus Infection, MMWR, 2023, tableau 1.

**Question 41. Une nouvelle vaccination contre l’hépatite B est-elle nécessaire chez cette gestante immunocompétente, dont le schéma vaccinal complet et l’immunité sont documentés ?**

A. Elle est nécessaire.

B. Elle n'est pas nécessaire.

Réponse : B — Elle n’est pas nécessaire

Explication : Chez cette patiente immunocompétente correctement vaccinée, une nouvelle série vaccinale n’est pas indiquée. Une vaccination incomplète aurait en revanche dû être complétée.

Source : CDC, Screening and Testing for Hepatitis B Virus Infection, MMWR, 2023, tableau 1.

**Question 42. Chez le nouveau-né de cette mère non infectée par le VHB et correctement vaccinée, quelles mesures sont appropriées ?**

A. Vaccination contre l'hépatite B avec dose de naissance, selon les recommandations.

B. Immunoglobulines anti-HBs systématiques au seul motif que la mère est vaccinée.

C. Arrêt de l'allaitement du fait de cette sérologie maternelle.

D. Allaitement autorisé.

Réponse : A et D

Explication : Le nouveau-né reçoit la vaccination anti-VHB recommandée et peut être allaité. Les immunoglobulines anti-HBs ne sont pas indiquées du seul fait d'une vaccination maternelle.

Source : OMS, Hepatitis B, prévention ; CDC, Hepatitis B Perinatal Vaccine Information.

**Question 43. Quel groupe de micro-organismes joue habituellement le rôle principal dans la protection d'un microbiote vaginal équilibré chez la femme en âge de procréer ?**

A. Lactobacilles.

B. Staphylocoques.

C. Chlamydiae trachomatis.

D. Candida albicans.

E. Gardnerella vaginalis.

F. Trichomonas.

Réponse : A — Lactobacilles

Explication : Les lactobacilles contribuent à l'acidité et à la protection du milieu vaginal. La présence possible de Candida ou de Gardnerella sans symptômes ne leur donne pas ce rôle protecteur principal.

Source : CDC, STI Treatment Guidelines, Bacterial Vaginosis, définition du microbiote dominé par les Lactobacillus ; Vulvovaginal Candidiasis.

**Question 44. Une vulvo-vaginite présentant les caractères suivants : leucorrhées blanchâtres, abondantes, grumeleuses, inodores, adhérentes à la paroi vaginale et associées à des prurits intenses est en faveur : (cocher la bonne réponse)**

A. Vaginose.

B. Chlamydiose.

C. Mycose.

D. Infection à Trichomonas.

Réponse : C — Mycose vulvovaginale

Explication : Le prurit intense et les pertes épaisses, blanchâtres et grumeleuses évoquent une candidose. La confirmation clinique ou microbiologique permet d'écarter d'autres causes.

Source : CDC, STI Treatment Guidelines, 2021, Vulvovaginal Candidiasis, Diagnostic Considerations.

**Question 45. Un nouveau-né reste apnéique après mise au chaud, séchage, stimulation et positionnement correct de la tête. Ses voies aériennes sont libres. Quel geste est prioritaire ?**

A. Injection de solutés.

B. Ventilation manuelle au ballon.

C. Désobstruction des voies aériennes.

D. Massage cardiaque.

Réponse : B — Ventilation au ballon et au masque

Explication : Après les gestes initiaux, l’apnée impose une ventilation efficace. L’aspiration n’est pas systématique si les voies aériennes sont libres. Les compressions ne précèdent pas une ventilation adéquate.

Source : PNSME, SOINS OBSTETRICAUX ET NEONATAUX D’URGENCE - SONU - PNSME (2).pdf, « Réanimation du nouveau-né », p. PDF 66–82. AHA/AAP, Neonatal Resuscitation Guidelines, 2025, ventilation et dégagement des voies aériennes.

**Question 46. Parmi les germes suivants, lequel est le plus fréquemment responsable d'une infection urinaire au cours de la grossesse ?**

A. Serratia marcescens.

B. Proteus mirabilis.

C. Escherichia coli.

D. Klebsiella pneumoniae.

Réponse : C — Escherichia coli

Explication : E. coli est la bactérie la plus fréquemment responsable des infections urinaires communautaires, y compris pendant la grossesse. L’ECBU et l’antibiogramme guident l’adaptation du traitement.

Source : Collège français des urologues, Référentiel d’urologie, 6e édition, chapitre 11 Infections urinaires.

**Question 47. Parmi les situations urinaires suivantes observées pendant la grossesse, laquelle correspond à la présence significative de bactéries à l’ECBU sans symptôme urinaire ?**

A. Cystite.

B. Bactériurie asymptomatique.

C. Pyélonéphrite.

Réponse : B — Bactériurie asymptomatique

Explication : Elle associe une bactériurie significative à l’absence de signes urinaires. La cystite provoque des symptômes vésicaux ; la pyélonéphrite est une infection du haut appareil urinaire.

Source : AP-HP, Pitié-Salpêtrière, Infection urinaire et grossesse, protocole du 28 janvier 2014, p. PDF 1.

**Question 48. Chez une femme ayant des facteurs de risque, sans diabète déjà identifié au début de la grossesse, quand réalise-t-on habituellement l’HGPO à 75 g pour rechercher un diabète gestationnel ?**

A. Avant la grossesse exclusivement.

B. Après l’accouchement exclusivement.

C. À 15 semaines d’aménorrhée systématiquement.

D. Entre 24 et 28 semaines d’aménorrhée.

E. Uniquement au premier trimestre, sans dépistage ultérieur.

Réponse : D — Entre 24 et 28 SA

Explication : L’HGPO à 75 g est habituellement réalisée à cette période chez les femmes concernées. Une glycémie à jeun peut aussi être demandée plus tôt chez les femmes à risque.

Source : CNGOF et SFD, Le diabète gestationnel, RPC 2010, sections Dépistage et Diagnostic.

**Question 49. L’insuffisance ovarienne prématurée correspond à une perte de la fonction ovarienne survenant avant quel âge ?**

A. 40 ans

B. 45 ans

C. 50 ans

D. 55 ans

Réponse : A — Avant 40 ans

Explication : Avant 40 ans, il faut évoquer une insuffisance ovarienne prématurée et réaliser un bilan adapté. Le terme précise mieux la situation que l’expression « ménopause précoce ».

Source : Société française d’endocrinologie, Item 124 Ménopause et insuffisance ovarienne prématurée, sections Périménopause, Diagnostic et Signes cliniques.

**Question 50. Au cours de la transition vers la ménopause, les cycles anovulatoires peuvent entraîner :**

A. Absence de sécrétion d'œstrogènes.

B. Hyperœstrogénie relative.

C. Augmentation de la progestérone.

D. Chute de la progestérone.

Réponse : B et D

Explication : L’irrégularité ovulatoire diminue la production de progestérone. L’action œstrogénique peut alors devenir relativement prédominante ; la sécrétion d’œstrogènes ne disparaît pas d’emblée.

Source : Société française d’endocrinologie, Item 124 Ménopause et insuffisance ovarienne prématurée, sections Périménopause, Diagnostic et Signes cliniques.

**Question 51. Quelles manifestations sont compatibles avec les symptômes climatériques de la ménopause ?**

A. Une sensation brusque de chaleur du visage, du cou ou du haut du thorax.

B. Des bouffées de chaleur débutant obligatoirement aux pieds.

C. Des bouffées de chaleur pendant la journée.

D. Des bouffées de chaleur ou sueurs pendant la nuit.

E. Des troubles du sommeil ou de l’humeur associés.

Réponse : A, C, D et E

Explication : Les bouffées touchent surtout le visage, le cou et le haut du corps. Elles peuvent survenir le jour ou la nuit et s’accompagner de troubles du sommeil ou de l’humeur.

Source : Société française d’endocrinologie, Item 124 Ménopause et insuffisance ovarienne prématurée, sections Périménopause, Diagnostic et Signes cliniques.

**Question 52. Parmi les agents suivants, quels sont les deux agents d’IST classiquement impliqués dans les infections génitales hautes ?**

A. Escherichia coli.

B. Staphylocoque.

C. Chlamydia trachomatis.

D. Neisseria gonorrhoeae, ou gonocoque.

Réponse : C et D

Explication : Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae sont deux agents d’IST impliqués dans les infections génitales hautes. Celles-ci peuvent également être polymicrobiennes.

Source : CDC, STI Treatment Guidelines, 2021, Pelvic Inflammatory Disease, étiologie.

**Question 53. À quel moment le sexe chromosomique est-il habituellement déterminé ?**

A. À la fécondation.

B. À la période embryonnaire.

C. À la période fœtale.

Réponse : A — À la fécondation

Explication : L'apport du chromosome sexuel du spermatozoïde détermine habituellement le sexe chromosomique dès la fécondation. La différenciation morphologique se produit ensuite.

Source : INFAS, GYNECO L1 .pdf, « Fécondation et développement embryonnaire », p. PDF 40.

**Question 54. Parmi les situations suivantes, laquelle permet une grossesse spontanée avec gestation dans un utérus fonctionnel ?**

A. Agénésie utérine bilatérale complète.

B. Aplasie utéro-vaginale de type Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, sans utérus fonctionnel.

C. Diaphragme vaginal perforé, avec utérus et trompes fonctionnels.

Réponse : C

Explication : Un diaphragme perforé peut laisser passer les spermatozoïdes. Une aplasie sans utérus fonctionnel ne permet pas de porter spontanément une grossesse, même si les ovaires fonctionnent.

Source : GFMER, Diagnostic échographique des malformations utérines, diapositive Aplasies müllériennes, p. PDF 16. CNGOF, malformations utérines et fertilité, Mises à jour en gynécologie et obstétrique, 2009.

**Question 55. Quelles situations correspondent à une mort fœtale antepartum, c'est-à-dire survenue avant le début du travail ?**

A. Décès fœtal à 22 SA, avant le travail.

B. Décès fœtal à 36 SA, avant le travail.

C. Décès fœtal pendant le travail, à 7 cm de dilatation.

D. Décès fœtal pendant l'expulsion.

Réponse : A et B

Explication : Antepartum signifie avant le travail. Les décès pendant la dilatation ou l'expulsion sont intrapartum ; cette distinction porte sur le moment du décès.

Source : CNGOF, Mort fœtale, 2024, définitions et classification antepartum/intrapartum.

**Question 56. Parmi les affections suivantes, laquelle est une cause vasculo-placentaire de mort fœtale in utero ?**

A. Paludisme et grossesse.

B. Hépatite virale.

C. Prééclampsie.

D. Toxoplasmose.

Réponse : C — Prééclampsie

Explication : La prééclampsie peut provoquer une insuffisance placentaire, un retard de croissance ou un hématome rétroplacentaire, avec risque de décès fœtal.

Source : INFAS, GYNECO L2 .pdf, « Hypertension artérielle, éclampsie et grossesse », p. PDF 78–83.

## Références documentaires


INFAS — GYNECO L1 .pdf, cours de première année, 2017–2018 ; GYNECO L2 .pdf, cours sage-femme licence 2 ; SR PF L2.pdf, licence 2 sage-femme, 2021–2022. Documents de cours consultés en priorité.

PNSME — SOINS OBSTETRICAUX ET NEONATAUX D'URGENCE - SONU - PNSME (2).pdf.

INS et ICF — EDS Côte d'Ivoire 2021, Rapport de synthèse, Mortalité maternelle.
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/SR280/SR280.pdf

OMS Afrique — Côte d'Ivoire améliorer la qualité des soins pour réduire le taux de la mortalité maternelle, 5 décembre 2024.
https://www.afro.who.int/fr/countries/cote-divoire/news/cote-divoire-ameliorer-la-qualite-des-soins-pour-reduire-le-taux-de-la-mortalite-maternelle

MSF — Soins obstétricaux et néonatals essentiels, présentation du siège, placenta prævia, travail et mort fœtale.
https://medicalguidelines.msf.org/sites/default/files/pdf/guideline-449-fr.pdf

OMS — Multiple definitions of infertility, 2020.
https://www.who.int/news/item/04-02-2020-multiple-definitions-of-infertility

CNGOF — Interventions gynécologiques, hystéroscopie.
https://cngof.fr/espace-grand-public/interventions-gynecologiques/

NCBI — Blood Groups and Red Cell Antigens, The ABO blood group.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2267/

OMS — Rubella, prévention et vaccination.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rubella

ENS de Lyon — La différenciation sexuelle morphologique, stade indifférencié.
https://acces.ens-lyon.fr/biotic/procreat/determin/html/diffsex.htm

GFMER — Diagnostic échographique des malformations utérines, p. PDF 16.
https://www.gfmer.ch/Presentations_Fr/Pdf/Echographie_malformations_uterines.pdf

CNGOF — Malformations utérines, Mises à jour en gynécologie et obstétrique, 2009.
https://cngof.fr/app/uploads/2023/06/2009_GO_253_chanelles.pdf

Société française d'endocrinologie — Item 124 Ménopause et insuffisance ovarienne prématurée.
https://www.sfendocrino.org/item-124-menopause/

OMS — Hépatite B, recommandations 2024.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240090903

OMS — Hepatitis B, prévention.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b

OMS — Use of BCG vaccine in HIV-infected infants.
https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety/topics/bcg-vaccines

CNGOF — Mort fœtale, consensus formalisé d'experts, 2024.
https://cngof.fr/app/uploads/2025/11/Mort20Foetale20202420CFE20.pdf

OMS et UNICEF — Maternal and perinatal death surveillance and response, 2021.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240036666

CDC — DPDx Toxoplasmosis, diagnostic sérologique.
https://www.cdc.gov/dpdx/toxoplasmosis/index.html

CDC — About Toxoplasmosis et Symptoms of Toxoplasmosis.
https://www.cdc.gov/toxoplasmosis/about/index.html

CDC — Pink Book, chapitre 20 Rubella.
https://www.cdc.gov/pinkbook/hcp/table-of-contents/chapter-20-rubella.html

OMS — Malaria, définition et agent responsable.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

CDC — Screening and Testing for Hepatitis B Virus Infection, 2023, tableau 1.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/rr/rr7201a1.htm

CDC — Hepatitis B Perinatal Vaccine Information.
https://www.cdc.gov/hepatitis-b/hcp/perinatal-provider-overview/vaccine-administration.html

CDC — STI Treatment Guidelines, 2021, Bacterial Vaginosis.
https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/bv.htm

CDC — STI Treatment Guidelines, 2021, Vulvovaginal Candidiasis.
https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/candidiasis.htm

CDC — STI Treatment Guidelines, 2021, Pelvic Inflammatory Disease.
https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/pid.htm

AHA et AAP — Neonatal Resuscitation Guidelines, 2025.
https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/neonatal-resuscitation

Collège français des urologues — Référentiel d’urologie, 6e édition, chapitre 11 Infections urinaires.
https://www.urofrance.org/lafu-academie/formation-du-college/referentiel-du-college-durologie-6eme-edition/chapitre-11-item-161-infections-urinaires-de-ladulte-et-de-lenfant/

AP-HP Pitié-Salpêtrière — Infection urinaire et grossesse, 28 janvier 2014.
https://pitiesalpetriere.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/179/files/2015/11/Ob-06-Infection-urinaire-et-grossesse-20140128.pdf

CNGOF et SFD — Le diabète gestationnel, RPC 2010.
https://cngof.fr/app/uploads/2023/06/RPC_DIABETE_2010.pdf